

部外秘

厚生労働省

特別疾病対策課

文書番号：厚労発特疾第 0415 号

発出年月日：令和 3 年（2021 年）4 月 15 日

部外秘・関係者限り

本マニュアルは関係職員以外への配布を禁ずる。

内因性銀イオン異常症候群（ESIAS） 対応研修マニュアル

各都道府県衛生主管部（局）長 殿
厚生労働省特別疾病対策課長
令和 3 年 4 月

研修のねらい

本研修は、保健所及び都道府県の担当職員が、ESIASに係る業務を適切に行えるようにすることを目的とする。研修（2日間）終了後、次のことができることを目標とする。

1. 医療機関からの報告（医師法に基づく届出）を受理し、保健所として調査・フォローができる。
2. 初回接触と同意取得を適切に行える。
3. 個人情報を適切に管理できる。
4. 等級別の対応（第3級は非接触）を理解する。
5. 都道府県・厚生労働省への報告を適切に行える。

第1章 総則

（目的）

第1条 このマニュアルは、内因性銀イオン異常症候群（ESIAS）に係る者の把握、登録、初回接触、同意取得及び支援の方法を定め、本人の権利を保障しつつ、公衆衛生の維持を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第2条 このマニュアルは、保健所、都道府県衛生主管部局及び厚生労働省特別疾病対策課の職員がESIASに係る業務を行う場合に適用する。

（基本原則）

- （1）本人の意思の尊重：同意なく支援を強制しない。
- （2）任意性：支援の受否は本人が決定する。
- （3）秘密保持：本人の情報は厳重に管理する。
- （4）非接触：第3級に該当する者には非接触方式で対応する。
- （5）非差別：本人を「対象」「異常」等と呼称しない。

第2章 事務分担

（所掌）

第3条 ESIASに係る事務は、厚生労働省特別疾病対策課が所掌する。平成27年（2015年）の制度移管により、従来警察庁が所管していた事務は厚生労働省に移管され、旧「桜花寮」に係る記録も引き継がれている。

（役割分担）

- （1）保健所：医療機関からの報告の受理、調査、初回接触、地域適応支援。
- （2）都道府県衛生主管部局：管内の調整、登録管理、都道府県から厚労省への報告。
- （3）厚生労働省特別疾病対策課：制度の企画、全国統計、研修の企画。

(4) 宮内庁及び環境省：第3級に係る非接触モニタリングを共同で実施。

第3章 把握・登録

(報告)

第4条 医師は、医師法に基づき、ESIASに係る者の報告を最寄りの保健所に行う。保健所はこの報告を受理し、必要な調査を行う。

(登録)

第5条 確認後、保健所は登録を行い、都道府県を経て厚生労働省特別疾病対策課に報告する。登録番号は「都道府県コード—年度—連番」とする。

(チェックリスト)

- ☐ 1. 医療機関からの報告を受理した。
- ☐ 2. 保健所として調査を行った。
- ☐ 3. 登録し、都道府県・厚労省に報告した。
- ☐ 4. 初回接触を計画した。
- ☐ 5. 秘密保持を確認した。

第4章 初回接触・同意

(初回接触)

第6条 初回接触は原則として職員2名で行う。職員は、身分を明らかにし、訪問の目的を説明し、医療的・社会的支援の選択肢を提示し、同意に係る説明を行う。

第7条 本人は支援を拒否することができる。拒否により不利益な取扱いを受けない。

(同意)

第8条 職員は、本人に対し、分かりやすい言葉で、血液中の銀イオンが非病理的濃度で存在すること、情緒と体調との関係、無料で受けられる支援の内容を説明し、同意を得る。宗教的又は疑似宗教的な表現は用いない。

第5章 等級別対応

(第1級)

第9条 第1級に該当する者には、同意の上、生活保護、職業訓練、地域適応支援等を提供する。

(第2級)

第10条 第2級に該当する者には、安定した社会的役割を提供する。就労は、神職補助、図書館司書、山間郵便局窓口職員、有機農業、伝統工芸継承者等、比較的対話の少ない職種を中心に斡旋する。

(第3級)

第11条 第3級に該当する者には、非接触方式により対応する。宮内庁及び環境省が共同で熱源モニタリングを実施し、接近・標識・問診は行わない。所在区域は都道府県を通じて管理する。

（第4級・第5級）

第12条 第4級及び第5級に該当する者の国内記録はない。記録が得られた場合は直ちに厚生労働省特別疾病対策課に報告する。

第6章 特別な場合・緊急時

（婚姻等）

第13条 本人が婚姻又は安定した関係を予定する場合、本人の同意を得た上で、本人、配偶者（相手方）、職員が立ち会う場で、既知の医学的事実と支援の内容を説明し、配偶者（相手方）に確認書の署名を求める。本人の同意なく配偶者（相手方）に告知しない。

（緊急時）

第14条 本人又は周囲の者に危険が及ぶおそれがある場合、第3級の者の所在区域に異変が生じた場合は、直ちに担当課長に報告し、必要に応じ関係機関と連携する。職員は単独で強制措置をとらない。

第7章 統計・研修

（統計）

第15条 保健所は四半期ごとに登録状況を都道府県を経て特別疾病対策課に報告する。

（研修）

第16条 新規担当職員は、このマニュアルを含む研修（2日間）を受け、確認試験に合格した後に業務に当たる。再研修は2年ごとに行う。

第8章 ケーススタディ・確認問題

ケース1 本人が支援を拒否

対応：拒否の意思を尊重し、記録する。以後、生理指標に著しい異常が生じ、公共安全に支障を及ぼすおそれがある場合に限り、委員会の審議を経て対応する。

ケース2 家族が「祟り」と言う

対応：その表現を繰り返さない。医学的表現で説明する。差別・暴力の兆候があれば担当課長に報告する。

ケース3 第3級の者の区域に異変

対応：直ちに担当課長に報告する。接近しない。遠隔で状況を評価する。

確認問題（例）

1. 医師の報告はどこに行われるか？（ ）
A. 警察署 B. 保健所 C. 市役所 D. 報道機関
2. 第3級の者の対応の原則は？（ ）
A. 月1回訪問 B. 非接触 C. 電話連絡 D. 保健指導
3. 配偶者に告知できる条件は？（ ）
A. いつでも B. 本人の同意がある場合 C. 家族の同意 D. できない
4. 「祟り」と言われた場合の対応は？（ ）
A. 繰り返す B. 医学的表現で説明 C. 神社を紹介 D. 無視する

様式

様式第1号 登録票

登録番号：_____ 登録年月日：____年__月__日
都道府県：_____ 保健所：_____
報告源：☐医療機関 ☐保健所調査 ☐その他
等級：☐第1級 ☐第2級 ☐第3級 ☐第4級 ☐第5級
登録者：_____ 確認者：_____

様式第2号 初回接触記録

登録番号：_____ 接触日：____年__月__日
接触方法：☐訪問 ☐来所 ☐その他
説明実施：☐あり ☐延期
本人の反応：☐同意 ☐拒否 ☐未定
職員：_____ / _____

様式第3号 同意書

私は、私の状態に関する既知の医学的事実と利用できる支援の内容について説明を受けました。支援の受否を（同意する・同意しない）ことを確認します。
本人署名：_____ 年月日：____年__月__日 立会人：_____

様式第4号 秘密保持誓約書

私は、ESIASに係る本人の情報を、在職中はもとより退職後も秘密として保持することを誓約します。
氏名：_____ 所属：_____ 年月日：____年__月__日

様式第5号 配偶者確認書

登録番号：_____ 年月日：____年__月__日
本人の同意を得て、配偶者（相手方）に既知の医学的事実と支援の内容を説明した。
本人署名：_____ 配偶者（相手方）署名：_____ 職員：_____

様式第6号 四半期報告書

都道府県：_____ 期間：____年__月～__月
登録数：_____ 新規：_____

第1級：____ 第2級：____ 第3級：____ 第4級：____ 第5級：____
担当：_____

様式第7号 研修受講簿

研修名：ESIAS 対応研修（2日間） 研修日：____年__月__日
氏名 所属 署名
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

附 則

- 1 このマニュアルは、令和 3 年 4 月 15 日から施行する。
- 2 このマニュアルの改廃は、厚生労働省特別疾病対策課が行う。

以上

担当：厚生労働省特別疾病対策課 〒100-8916 東京都千代田区霞が関 1-2-2

部外秘・関係者限り